SYNDROME VESTIBULAIRE

DR
R.CHENNA

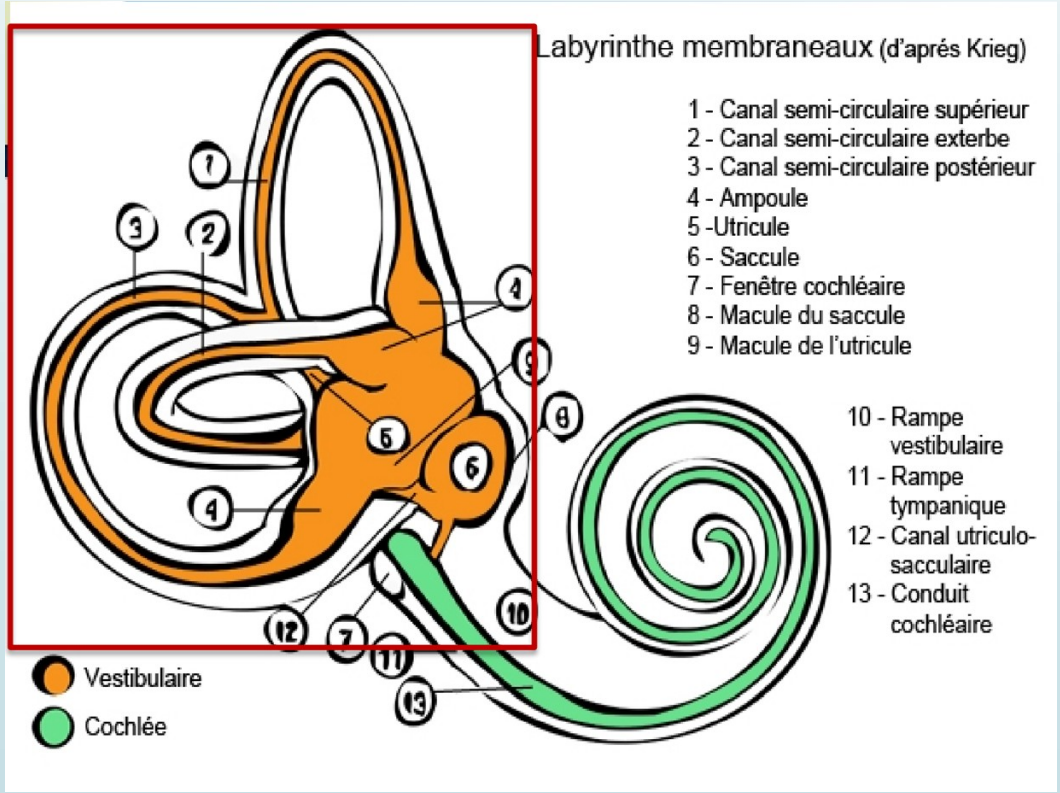
INTRODUCTION

- Les syndromes vestibulaires traduisent l’atteinte uni- ou bilatérale, aiguë ou chronique, du système vestibulaire, celui-ci comprenant les récepteurs labyrinthiques, les nerfs et noyaux vestibulaires ainsi que leurs projections efférentes oculomotrices et spinales.

RAPPEL ANATOMIQUE

Le LABYRINTHE VESTIBULAIRE comprend

- 3 canaux semi-circulaires
- 2 capteurs sensoriels sensibles aux accélérations linéaires (Utricule / Saccule)



RAPPEL ANATOMIQUE

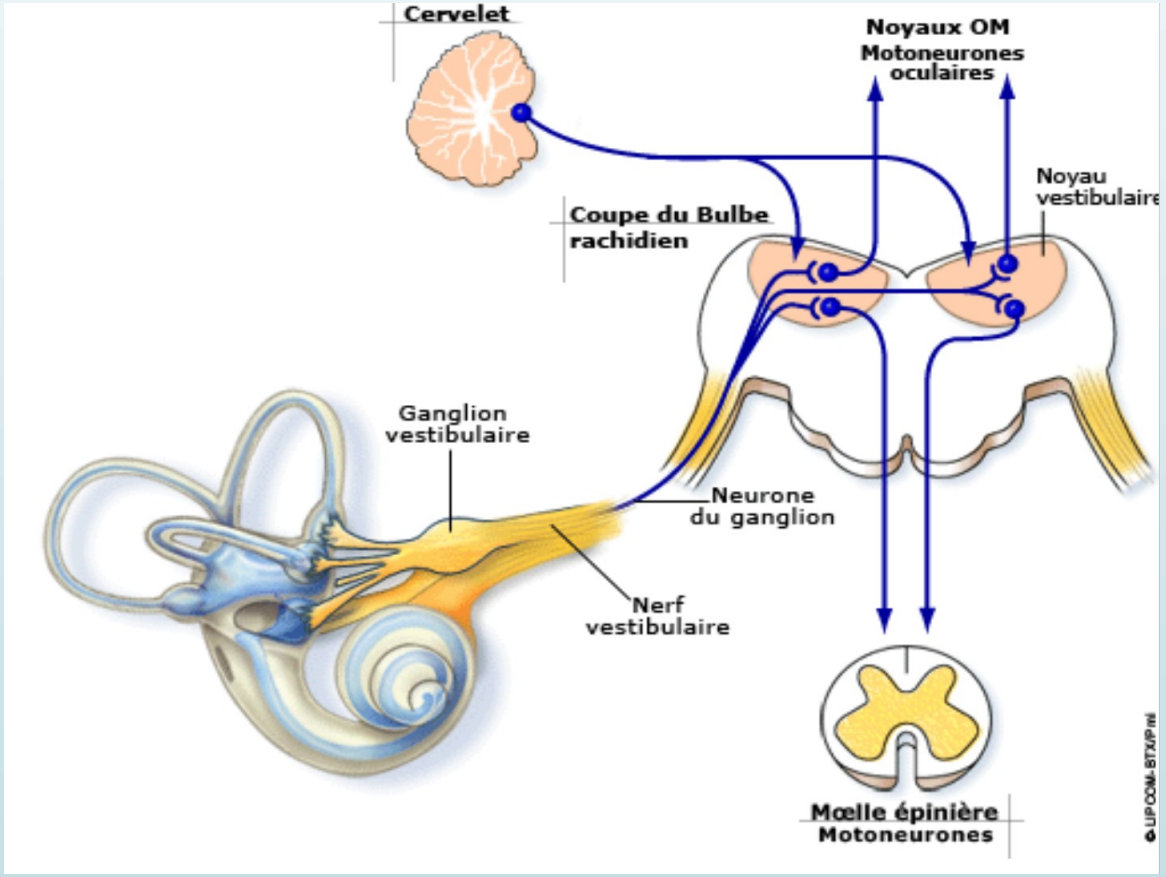
Noyau de Scarpa ou ganglion vestibulaire

VIIIème nerf ou nerf cochléovestibulaire

Noyaux vestibulaires

L’intégrateur: flocculus

Le cervelet: l’adaptateur



SEMIOLOGIE

SIGNES SUBJECTIFS.

- ***Le vertige*** en constitue la manifestation majeure. Il s'agit d'une sensation de déplacement, rotatoire, des objets environnants par rapport au sujet ou du sujet par rapport aux objets environnants. et se produit dans un plan vertical ou dans un plan horizontal.
- ***Les signes d'accompagnement*** sont constants et le sujet ressent l'impression pénible, souvent angoissante, d'une perte de l'équilibre.
  - ***Les troubles de l'équilibre*** peuvent être à l'origine de chutes lors de la survenue du vertige qui rend la position debout impossible; ailleurs, on notera des troubles de la marche.
  - ***Les nausées et les vomissements,*** réveillés par le moindre mouvement, sont très fréquents et s'accompagnent de réactions vaso-motrices telles que pâleur, sueurs, ralentissement du pouls.

SEMIOLOGIE

SIGNES OBJECTIFS.

- ***A) Le nystagmus*** en est le maître symptôme. Il s'agit d'un mouvement d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire , la secousse lente est dirigée vers le côté malade, puis la secousse rapide « rattrape » ce décalage, battant du côté sain.

Le sens du nystagmus est donné par la secousse rapide.

- ***Le nystagmus vestibulaire***, qui se définit par le sens de sa secousse rapide, peut être horizontal (droit ou gauche), vertical (vers le haut ou vers le bas), rotatoire (horaire. ou antihoraire), enfin mixte (horizontal-rotatoire).

SEMIOLOGIE

B) Les troubles de l'équilibre.

- ***Les troubles de la statique.***

Lorsque le sujet est debout, les pieds joints, on voit survenir une inclinaison lente du corps qui se fait en règle latéralement (latéropulsion), plus rarement en avant ou en arrière (anté ou rétropulsion), mais toujours dans une même direction pour un individu donné. Ce trouble de la statique s'accentue lors de l'occlusion des yeux (signe de Romberg labyrinthique), mais la déviation du corps n'apparaît qu'après un temps de latence, s'installe lentement.

La déviation des index se recherche sur un sujet debout. dont les yeux sont fermés et à qui on demande de tendre les bras horizontalement en avant, les deux index étant pointés face à ceux de l'examinateur placé devant lui. on observe l'apparition d'une déviation lente des deux index dans le plan horizontal, déviation dont on note la direction et l'importance.

SEMIOLOGIE

- ***Les troubles de la marche.***

Le labyrinthique a tendance à dévier de la ligne droite au cours de la marche en raison des pulsions qu'il subit. ces, pulsions étant habituellement latérales et le sujet corrigeant volontairement la déviation, la marche se fait en zigzaguant avec conservation de la direction suivie.

Ces troubles sont bien mis en évidence par l'épreuve de la «marche en étoile» qui consiste à demander au sujet de marcher alternativement en avant, puis en arrière, les yeux fermés. Dans ces conditions on observe la marche dite en étoile de Babinski-Weill.,

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

- ***Les épreuves vestibulaires***

consistent à provoquer l'excitation des canaux semi-circulaires par une stimulation calorique, galvanique ou rotatoire, et à analyser le nystagmus oculaire et les déviations des membres ainsi provoqués, en notant leur type et leur intensité.Ils déterminent le degré d'excitabilité labyrinthique : hyper, hypo ou inexcitabilité qui pourra être uni ou bilatérale. L'atteinte peut être globale, affectant au même degré les différents types de nystagmus provoqués et les déviations subies; elle peut être partielle, affectant de façon élective un type de réaction, par exemple le nystagmus rotatoire.

- ***L'électro-nystagmographie*** permet l'enregistrement des différents types le nystagmus, spontanés ou provoqués.
- ***TDM et IRM :*** viendront compléter les investigations

Le syndrome vestibulaire périphérique :

La lésion siège soit au niveau des récepteurs (labyrinthe), soit au niveau du nerf vestibulaire.

Les symptômes sont les suivants :

— Vertiges rotatoires intenses, déclenchés par les changements de position accompagnés de nausées et de vomissements.

— Troubles importants de l'équilibration avec déviation des index. — Nystagmus horizontal.
— Les épreuves instrumentales montrent une hypo-excitabilité ou une inexcitabilité unilatérale. Le

syndrome vestibulaire périphérique réalise un syndrome vestibulaire harmonieux, car il y a concordance entre les signes cliniques et le résultat des manœuvres instrumentales.

Le syndrome vestibulaire périphérique :

Les causes du syndrome vestibulaire périphérique sont variées :

— Les causes labyrinthiques sont : traumatiques (fracture du rocher), infectieuses (otite, mastoïdite), vasculaires (hémorragies labyrinthiques) et le syndrome de Ménière.

Le syndrome de Ménière ou Vertige de Ménière : semble en rapport avec des poussées d'hyperpression du liquide endolymphatique, chaque poussée se traduit par de grands épisodes vertigineux associés à une atteinte cochléaire avec hypoacousie.

— L'atteinte du nerf vestibulaire se voit au cours du zona, du traitement par la Streptomycine

Le syndrome vestibulaire central

la lésion siège soit au niveau des noyaux vestibulaires, soit au niveau des connexions centrales.

Les symptômes sont les suivants :

- Les vertiges sont discrets.
- Les troubles de l'équilibration ne sont pas franchement latéralisés, ils sont multidirectionnels.
- Le nystagmus est très marqué : il est le plus fréquemment horizontal, il est parfois vertical, il signe une atteinte pédonculaire ou rotatoire, il signe alors une atteinte bulbaire.
- Les épreuves instrumentales sont le plus souvent normales, ce qui a valu au syndrome vestibulaire central le qualificatif de dysharmonieux.
- L'atteinte du nerf cochléaire est rare.
- Signes associés : ce sont des signes d'atteinte du tronc cérébral : troubles oculomoteurs et troubles cérébelleux.

Le syndrome vestibulaire central

- Les causes du syndrome vestibulaire central sont variées : vasculaires (hémorragie ou ischémie du tronc cérébral), la sclérose en plaques, les tumeurs du tronc cérébral.

	PERIPHERIQUE	CENTRAL
SIEGE	RECEPTEURS ou VIII PERIPHERIQUE	Nx VEST OU CONNEX CENTRALES
VERTIGES	+++ ROTATOIRES	DISCRETS
TROUBLES EQUILIBRE	++++	MULTIDIRECTIONNELS
NYSTAGMUS	HORIZONTAL	+++ V → PEDONCULAIRE R → BULBAIRE
INSTRUMENTS	HYPO OU INEXCITABILITE	IRM, TDM
S. ASSOCIES	DEVIATION INDEX	TBLES OCULO-MOTEURS + SYND. CEREBEL
CAUSES	- LABYR: otite, mastoïdite, fracture rocher, Hgie labyr. MENIERE: Hypoacousie, vertiges +++ lésion VIII: Zona, SM	AVCH Ou AVCI du TC Sep, TUMEUR TRONC C